随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

主闭时,主A不仅往外周流血,还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室,导致主动脉里的舒张压显著↓→脉压显著↑

2.**周围血管征**（收缩压↑+舒张压↓致**脉压显著↑**）双枪波冲头

股动脉 Duroziez 双重音（d-double）	将听诊器放在股动脉处可闻及收缩期和舒张期的双期吹风样杂音
股动脉枪击音 Traube（Trump-枪）	将听诊器放在股动脉处可闻及和心跳一致的短促响亮如射枪般的嗒-嗒音
毛细血管搏动征	用手指轻压患者指甲末端或嘴巴使局部发白 当心脏收缩和舒张时发白的局部边缘发生有规律的红白交替改变
水冲脉 water-hammer pulse	将患者手腕逐渐高举过头、可感觉脉搏骤起骤落
点头征 De Musset（d-dian）	颈动脉搏动增强、出现与心跳一致的点头样运动

（三）治疗

瓣膜**置换术** 无论主闭还是主狭,一般都直接换瓣膜

（四）鉴别诊断

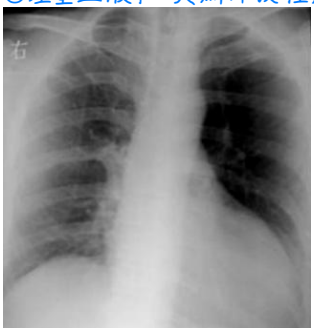
1.**心尖低调隆隆样舒张期杂音**

	器质性二尖瓣狭窄	Austin-Flint 杂音 相对性二狭
病因	风湿病等	**慢性严重主动脉瓣关闭不全**
杂音特点	**粗糙，≥3/6 级**	柔和，≤3/6 级
心尖震颤（器质性）	**常有**	无
出现时机	紧随开瓣音后额外心音	紧随 S_3 后
S_1	**增强**	**减弱**
心脏体征	**左室正常或缩小**	**左室增大、心尖抬举样搏动**
X 线	**梨形心**	**靴形心**
房颤	常有	不常有

器质性二狭　心音→额外　心音→杂音　主A　左房　舒张期　左室

左室问题　左心室搏动有力　另外三个瓣膜病都可出现

Austin-Flint杂音（①左室舒张期不仅接受主A反流的血,还接受从左心房过来的血,两种方向的血液碰到一起会产生涡流产生杂音
②左室血液↑二尖瓣开放程度↓(把二尖瓣抬起来)）







2.**G-S VS A-F 杂音**

	Graham-Steell 杂音	Austin-Flint 杂音
机制	严重肺动脉高压致肺动脉扩张	二尖瓣位置较高、涡流
器质性病变	**二尖瓣狭窄**	**主动脉瓣关闭不全**
功能性病变	**相对性肺动脉瓣关闭不全**	**相对性二尖瓣狭窄**
杂音特点	**胸骨左缘 2 肋间**	**心尖**
	舒张早期	**舒张期**
	递减型，高调叹气或吹风样	**低调隆隆样**